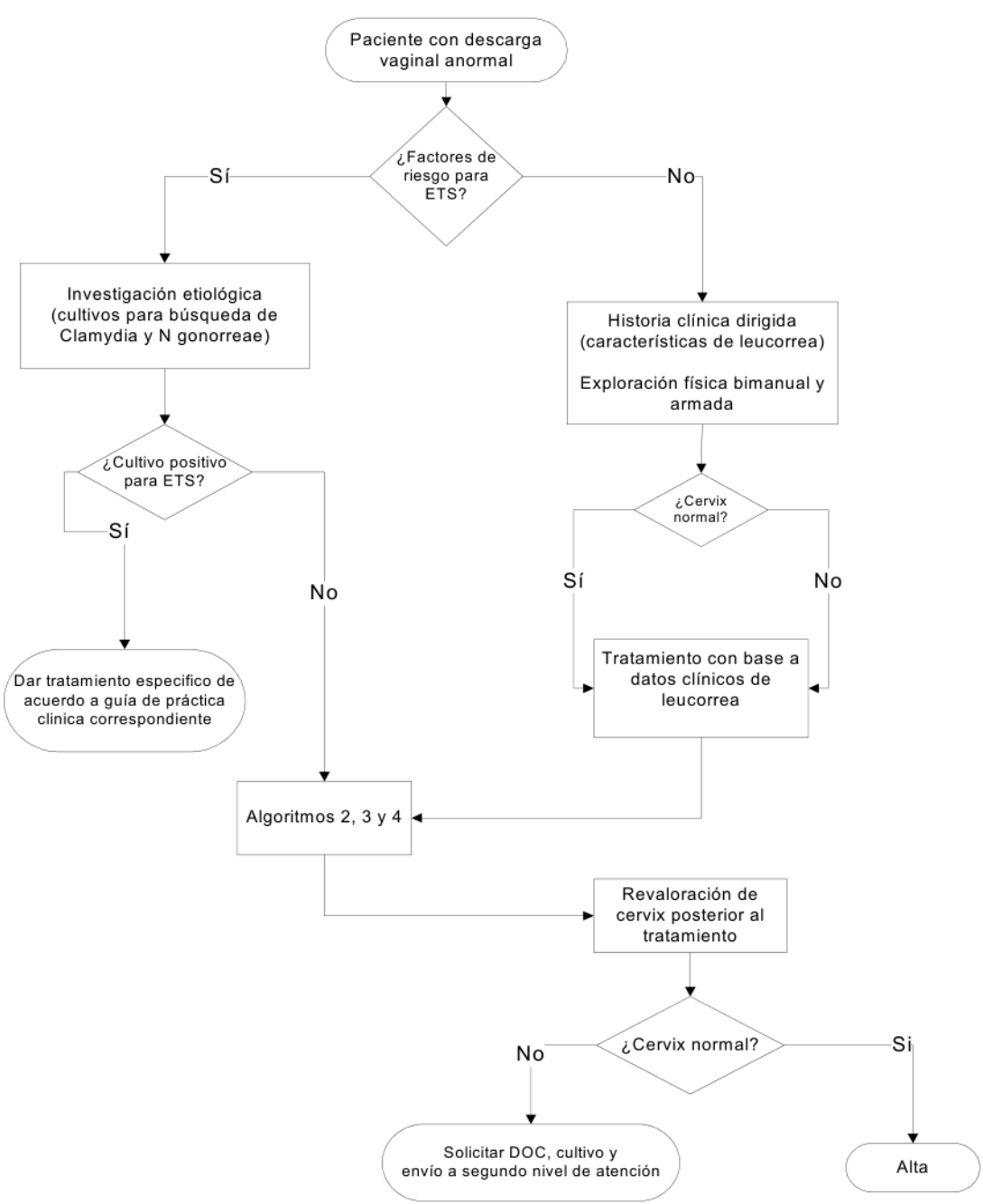


Imagen 1/10: CERVICOVAGINITIS_GPC.pdf-0015-04.png

E	*Candida sp*. forma parte de la biota normal de vulva y vagina, sin causar sintomatología. La candidosis vulvovaginal afecta al 75% de las mujeres al menos una vez en su vida. La Candidosis vulvovaginal (CVV) implica la inflamación de la vagina que frecuentemente involucra vulva, causada por la acción patógena de *Candida sp*. El diagnóstico se basa en la combinación de criterios clínicos y de laboratorio	**4** **NICE** *Sherrard J, 2018* *van Schalkwyk J, 2015*
E	En un estudio retrospectivo realizado en Túnez se obtuvieron 2,160 muestras de exudado vaginal recolectado en 2 años, se reportó que *Candida albicans* se aisló con mayor frecuencia (76.61%) seguido de *Candida glabrata*. (17.18%). La frecuencia máxima de cultivos positivos para Candida fue en mujeres entre 25 a 34 años de edad.	**3** **NICE** *Mtibaa L, 2017*
E	Se clasifica a la CVV en: No complicada y Complicada. La ***CVV no complicada o episódica***: se presenta en mujeres previamente sanas con sintomatología de leve a moderada y sin antecedentes de síntomas ***persistentes o recurrentes,*** con menos de 4 episodios al año.	**3, 4** **NICE** *Ragunathan L, 2014* *Pappas PG, 2016*
E	La ***CVV complicada*** se puede presentar como: • ***CVV grave***: cuando a la exploración se encuentran ***signos intensos*** de eritema vulvar extenso, edema, escoriaciones y fisuras, esto puede incluir a la CVV episódica con sintomatología grave o infección persistente por Candida no albicans.	**3, 4** **NICE** *Ragunathan L, 2014* *Pappas P, 2016*
E	La ***CVV recurrente o persistente*** se presentan en hospederos susceptibles con una condición subyacente como: embarazo, diabetes mellitus, infección por VIH, entre otras y se define a la presencia de 4 o más episodios de CVV en un periodo de un año	**4** **NICE** *Mendling W, 2015*

	Es importante que el clínico reconozca si existe comorbilidad subyacente y diferencie entre ***CVV no complicada y complicada***, para la toma de decisión de tratamiento y referencia a otros niveles de atención.	**Punto de buena práctica**
	Los probables factores de riesgo para CVV, incluyen: • Sólo el embarazo se correlacionó positivamente con el desarrollo de la CVV • factores fisiológicos, sobrepeso, período pre menstrual • diabetes mellitus (Inmunosupresión endógena) • inmunosupresión exógena (tratamiento inmunosupresor, corticoides) • antibióticos sistémicos • uso de los diferentes anticonceptivos De acuerdo a la evidencia revisada, a excepción del embarazo el resto de los factores mencionados no son consistentes como factor de riesgo para el desarrollo de la CVV.	**2+, 4 NICE** *Sherrard J, 2018* *van Schalkwyk J, 2015* *Martin JE, 2015* *Mtibaa L, 2017*
	Con respecto al embrazo se propone que un desequilibrio hormonal predominante de la progesterona, provoca un cambio en el epitelio vaginal y una disminución del pH vaginal, permitiendo la implantación de levaduras de Candida. La alta concentración de progesterona también es responsable del aumento del contenido de glucógeno en el tejido vaginal, que proporciona una fuente de carbono para el crecimiento y la germinación de Candida. Además, los estrógenos en el embarazo aumentan la avidez de las células epiteliales vaginales por la adherencia de Candida y la formación de	**3, 4 NICE** *Mtibaa L, 2017*

R	Es aconsejable que el examen físico en la mujer con sospecha de CVV incluya: palpación abdominal en busca de dolor, evaluación de la vulva, revisión con espejo vaginal con inspección de paredes vaginales y cérvix; evaluar las características de la secreción: cantidad, consistencia, así como el examen pélvico bimanual en la integración de diagnóstico de probabilidad y diagnóstico diferencial.	**D** **NICE** *Sherrard J, 2018*
R	Se recomienda utilizar los criterios para el diagnóstico de ***probabilidad y certeza*** de la CVV, resultando una mayor certidumbre para la toma de decisiones terapéuticas y la vigilancia de la respuesta clínica	**D** **NICE** *Sherrard J, 2018*
E	En las pacientes con sospecha de CVV no complicada se debe considerar la toma de los siguientes paraclínicos: • examen en fresco con observación directa al microscopio de muestra del exudado vaginal (de las paredes vaginales), con una preparación con solución salina al 10% de KOH y del frotis teñido: tinción de Gram, en busca de levaduras en gemación, hifas o pseudohifas • preferentemente debiera también hacerse cultivo para determinar la especie de Candida.	**4** **NICE** *Workowski KA, 2015* *Mendling W, 2015* *Pineda J, 2017*
E	En las pacientes con criterios clínicos de CVV complicada se debe tomar muestra de exudado vaginal para examen en fresco y cultivo; ya que es esencial determinar la especie de Candida. Reconociendo que *Candida albicans* representa el 85% a 90% de los casos de candidosis vulvovaginal y *Candida glabrata* representa casi la totalidad de los casos restantes.	**2-, 3** **NICE** *Hainer BL, 2011* *Sherrard J, 2018*
E	Las vulvovaginitis infecciosas a tomar en cuenta en el diagnóstico diferencial de CVV son: • Vaginosis bacteriana • Trichomoniasis	**3, 4** **NICE** *Sherrard J, 2018* *Schalkwyk J, 2015*
E	Los elementos diferenciales de CVV son: • características del flujo vulvovaginal • Prurito • escoriación vulvar • lesiones satélites (cuadro 1)	**4** **NICE** *Sherrard J, 2018* van Schalkwyk J, 2015 *Mendling W, 2015*

	Si se cuenta con los recursos de personal, insumos y equipo para realizar el examen en fresco, éste siempre deberá solicitarse ante la sospecha de CVV. En caso de no contar con lo anterior, las pacientes que reúnan criterios clínicos de CVV no complicada, podrán ser tratadas empíricamente	**Punto de buena práctica**
	Cuando se trata de pacientes con CVV complicada y se carece de los recursos de personal, insumos y equipo para realizar el examen en fresco, se recomienda su envío al siguiente nivel de atención	**Punto de buena práctica**
	Es necesario que el médico de primer contacto realice diagnóstico diferencial basado en la descripción del cuadro clínico: eritema y el edema de tejidos vulvares y vaginales, acompañados de prurito y secreción (exudado, flujo) vaginal espesa y blanca. De ser factible realizar examen en fresco del exudado de secreción vaginal.	**C, D** **NICE** *Sherrard J, 2018* *van Schalkwyk J, 2015* *Mendling W, 2015*
	Considerar que los episodios agudos de CVV en apariencia causados por *Candida sp.*, muy frecuentemente son manejados empíricamente basados en la sintomatología de la paciente o auto medicados con antimicóticos, sin embargo no son elementos suficientes para elaborar el diagnóstico clínico de la CVV no complicada.	**D** **NICE** *Pineda J, 2017*

E	El itraconazol causa significativamente más efectos secundarios durante el tratamiento sistémico comparado con el fluconazol, por ejemplo, reacciones anafilácticas, cefalea, etc.	**2+, 4 NICE** *Sherrard J, 2018* *Workowski KA, 2015* *Mendling W, 2015*
R	La decisión para prescribir o recomendar un tratamiento antimicótico en la paciente con CVV no complicada en relación a la vía de administración por vía bucal o intravaginal debiera considerar: • Costo • preferencias de tratamiento de las pacientes • contraindicaciones	**B, D NICE** *Sherrard J, 2018* *Workowski KA, 2015*
R	Se recomienda que antes de indicar un tratamiento para CVV se tomen en cuenta las preferencias de la paciente así como alergias, intolerancia y posibles reacciones adversa	**D NICE** *Workowski KA, 2015*
E	En la CVV no complicada: leve a moderada o periódica considerar regímenes farmacológicos cortos o de dosis única de acuerdo a los medicamento disponibles como: • Nistatina 100 000 U, una tableta u óvulo vaginal, por vía vaginal durante 14 días • Fluconazol 150 mg por vía oral, dosis única • Itraconazol 200 mg por vía oral, dos veces al día, durante un día • Isoconazol 600 mg óvulo vaginal, dosis única La aplicación tópica de los azoles es más efectiva que la nistatina. El tratamiento con azoles da como resultado el alivio de los síntomas y cultivos negativos en 80% -90% de pacientes que completan la terapia	**2+, 4 NICE** *Sherrard J, 2018* *Workowski KA, 2015* *Pineda J, 2017*
E	En una revisión sistemática se concluyó en mujeres con CVV no complicada no embarazadas: • Los imidazoles intravaginales reducen los síntomas de la CVV en pacientes no embarazadas. • Los imidazoles intravaginales: butoconazol, clotrimazol, Miconazol, pueden reducir los síntomas en comparación con el placebo, y todos parecen tener una eficacia similar al compararse entre sí. • Los imidazoles intravaginales: clotrimazol, miconazol y	**2++ NICE** *Martin JE, 2015*

E	Otros tratamientos intravaginales no disponibles en la institución son: • comprimidos vaginales de Clotrimazol 500 mg una sola vez o 200 mg una vez al día durante 3 días • Miconazol óvulo vaginal 1200 mg en una sola dosis o 400 mg una vez al día durante 3 días	**2+, 3** **NICE** *Sherrard J, 2018* *Workowski KA, 2015*
E	La nistatina intravaginal reduce los síntomas en comparación con el placebo, sin embargo no existen estudios que comparen: imidazoles intravaginales, fluconazol oral o itraconazol oral.	**2++** **NICE** *Martin JE, 2015*
R	El médico tratante debe considerar el beneficio del tratamiento antimicótico empírico ante la falta de herramientas diagnósticas útiles en mujeres con CVV no complicada en mujeres consideradas con bajo riesgo de enfermedad por transmisión sexual y que no presenten síntomas de infección de tracto reproductivo, requiriendo seguimiento a corto plazo y en caso de falta de respuesta clínica derivar al siguiente nivel de atención	**D** **NICE** *Pineda J, 2017*
E	En la CCV complicada indicar Fluconazol 150 mg por vía bucal una dosis y repetir a las 72 h una segunda dosis La CVV en hospederos con enfermedades subyacentes: diabetes, VIH, manejo con corticoesteroides, ya identificada: • Control de la comorbilidad enfermedad • No prescribir tratamiento corto • Nistatina 100 000 UI una tableta u óvulo vaginal, por vía vaginal durante 14 días • O fluconazol 100 mg, 150 mg o 200 mg por vía bucal cada tercer día por tres dosis (días 1, 4 y 7).	**2+, 4** **NICE** *Sherrard J, 2018* *Pineda J, 2017* *Workowski KA, 2015* *Martin JE, 2015*

R	Candidosis vulvovaginal recurrente. Tratamiento de inducción: • Nistatina 100 000 U, una tableta u óvulo vaginal, por vía vaginal durante 14 días, o durante 21 días en caso de enfermedad por C. glabrata • O Fluconazol 100 mg, 150 mg o 200 mg por vía bucal cada tercer día por 3 dosis (días 1, 4 y 7). Tratamiento de mantenimiento: • Fluconazol 100mg, 150 mg o 200 mg por vía bucal una sola dosis, una vez por semana, durante 6 meses.	**A** **NICE** *Delrene DJ, 2011*
E	En un estudio aleatorizado, doble ciego se incluyeron 343 mujeres se administró 150 mg de fluconazol o placebo una vez por semana durante 6 meses. Al termino del tratamiento, 90.8 % del grupo de tratamiento con fluconazol y 35.9 % del grupo placebo estaban en remisión. 6 meses después de terminada la terapia, 42.9 % del grupo de tratamiento fue asintomático frente al 21,9 % del grupo placebo	**2+** **NICE** *Delrene DJ, 2011*
E	En otro estudio en mujeres con CVV en las que utilizo itraconazol y clotrimazol se observaron tasas de curación clínica a 6 meses de 66.7% del grupo con itraconazol y 100 % del grupo con clotrimazol	**2+, 4** **NICE** *Sherrard J, 2018* *Workowski KA, 2015*
R	Se recomienda que los médicos pretendan lograr la ***remisión micológica*** en mujeres con CVV recurrente antes de iniciar terapia de mantenimiento en las pacientes. • Los regímenes adecuados para la remisión micológica incluyen 7 a 14 días de terapia tópica o fluconazol vía bucal (100, 150 o 200 mg) cada tercer día para un total de 3 dosis. • Los regímenes de mantenimiento incluyen fluconazol vía bucal (100, 150 o 200 mg) una vez por semana durante 6 meses o, si no es factible, 200 mg de crema tópica de clotrimazol 2 veces por semana	**C, D** **NICE** *Sherrard J, 2018* *Workowski KA, 2015* *Delrene DJ, 2011*

	Las mujeres con CVV que debieran ser enviadas del primer nivel de atención al segundo nivel de atención al servicio de Ginecología, son aquellas con ***CVV no complicada*** que recibieron ***tratamiento empírico*** y no hubo respuesta. A fin de que a las pacientes se les practiquen los exámenes paraclínicos necesarios, se establezca el diagnóstico etiológico de certeza y se prescriba tratamiento específico.	**Punto de buena práctica**
	Las pacientes con ***CVV recurrente*** que debieran ser enviadas de segundo nivel al tercer nivel de atención, son aquellas mujeres con ***CVV complicada*** en las que se ha identificado el agente causal pero se carece de recursos de laboratorio para identificación de la especie de Candida, así como la imposibilidad de determinación de resistencia, esto con el objetivo de identificar la especie e iniciar tratamiento específico. El envío será al servicio de Infectología en el tercer nivel de atención.	**Punto de buena práctica**

Documento de origen: Gpc candidiasis.pdf

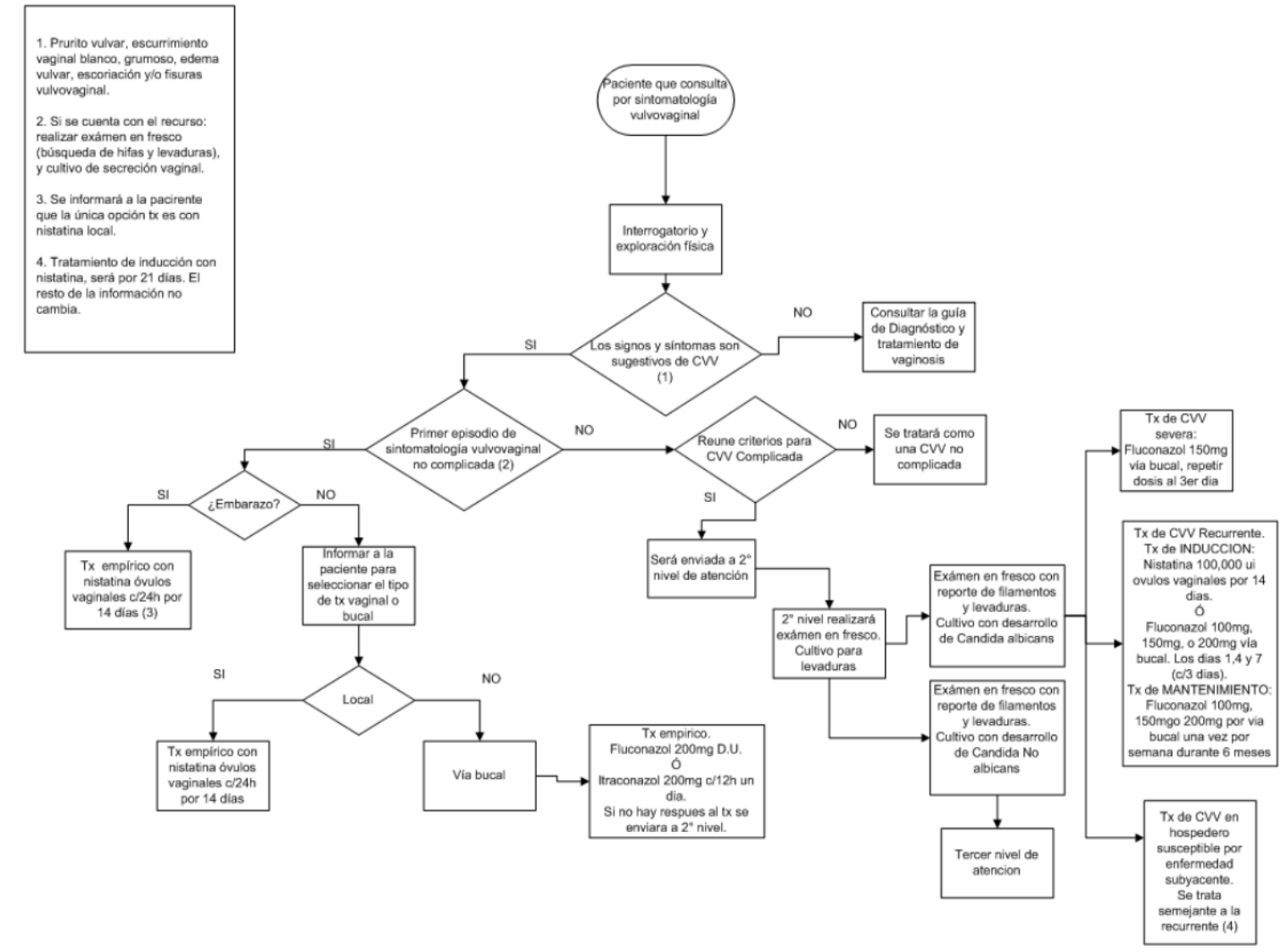


Imagen 10/10: Gpc_candidiasis.pdf-0027-01.png